

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 한 번 빠지면 꼭 다시 빠지나요?

모두 재발하는 것은 아닙니다. 나이·활동량과 관절
와순·뼈 손상 정도에 따라 재발 위험이 달라집니다.

Q2 직접 어깨를 맞춰도 되나요?

안 됩니다. 골절·신경·혈관 손상을 확인한 뒤 의료
진이 안전하게 정복해야 합니다.

Q3 방카르트 병변이 무엇인가요?

전방 탈구 때 관절와의 앞아래쪽 관절와순이 뼈에서
떨어지거나 찢어진 상태입니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 외상 뒤 어깨 모양이 변하고 팔을 움직일 수 없음
- 팔·손이 저리거나 차갑고 창백해짐, 통증이 매우 심함

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

탈구 횟수·활동 수준과 X-ray·MRI·CT를 함께 보고
관절와순, 뼈 손실과 동반 손상을 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 어깨 관절경

진찰과 영상을 직접 설명하고 재활부터
관절경 봉합술, 골 손실 치료까지 개인
별 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 X-ray·MRI·CT CD와 판독지
- 어깨를 맞춘 날짜와 탈구·아탈구 횟수
- 운동·직업 동작과 불안정감이 생기는 자세

대표 전화 031-328-0333

용인특례시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사 결과에 따라
달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

어깨 탈구와 방카르트 병변

어깨가 빠졌거나 반복해서 빠질 듯한 느낌,
관절와순과 뼈 손상을 함께 확인합니다.

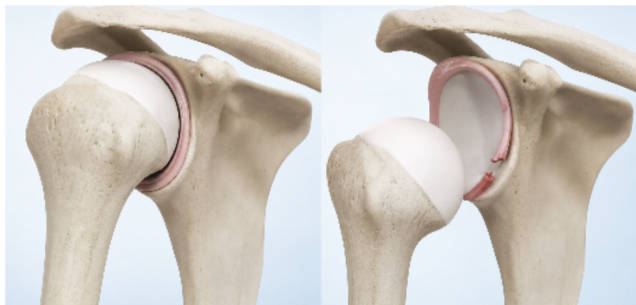


관절경 방카르트 봉합술

첫 탈구가 모두 수술 대상은 아닙니다. 재발 위험·활동 수
준·관절와와 상완골의 뼈 손실을 함께 보고 결정합니다.

01 질환·증상

어깨 탈구는 상완골두가 관절와에서 빠진 상태입니다. 흔한 전방 탈구 때 앞아래쪽 관절와순이 떨어지면 방카르트 병변이라고 합니다.



이런 증상을 확인합니다

- 어깨가 빠지거나 반복해서 헐거운 느낌
- 팔을 들고 뒤로 젖힐 때 빠질 듯한 불안감
- 외상 뒤 통증·힘 빠짐·걸리는 느낌

진단의 핵심

진찰과 X-ray로 정렬·골절을 확인하고, MRI로 관절와순·관절낭을 봅니다. 반복 탈구나 뼈 손상이 의심되면 CT로 골 손실을 평가합니다.

02 치료 선택

처음 빠진 횟수만 보지 않습니다. 나이·재발·운동과 직업, 관절와순 상태와 뼈 손실을 함께 보고 치료 방향을 정합니다.

먼저 하는 치료

- 응급실에서 영상 확인 후 안전하게 정복
- 지시에 따른 보조기·냉찜질·통증 관리
- 관절 움직임과 회전근개·견갑골 재활

수술을 검토할 때

- 탈구·아탈구가 반복되거나 불안정감이 지속될 때
- 재활 뒤에도 운동·직업·일상 기능이 제한될 때
- 재발 위험이 높고 봉합 가능한 관절와순 손상이 있을 때

치료의 흐름

응급 정복



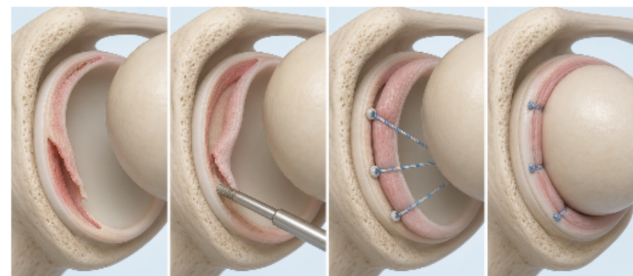
관절와순·뼈 손실
재평가



재활 또는
필요 시 수술

03 수술·회복

관절경 방카르트 봉합술



- 가 앞아래쪽 관절와순 파열과 동반 손상을 확인
- 나 관절와순을 움직일 수 있게 정리하고 뼈 부착 면을 준비
- 다 관절와 가장자리에 봉합 나사못을 고정하고 실을 통과
- 라 관절와순과 관절낭을 원래 위치에 밀착해 안정성을 확인

회복은 안정성과 기능에 맞춰

- 초기: 보조기·상처·통증 관리와 봉합 부위 보호
- 중기: 지시에 따라 수동 운동 뒤 근력 운동
- 후기: 가동 범위·근력·안정성 평가 후 일상·운동 복귀

알아둘 위험과 한계

감염, 관절 강직, 재탈구·재파열, 신경·혈관 손상, 나사못 문제, 잔여 통증, 마취 합병증 등이 있을 수 있습니다. 뼈 손실이 크면 다른 안정화 수술이 필요할 수 있습니다.